Pediatria: Resumo Definitivo para a Somativa

Nov 13, 2026 · @Luis Augusto Lobão Mendes

Como usar este material

Este documento cobre as 14 aulas da pasta (não existe Aula 14), na ordem do curso. Cada aula segue a mesma lógica: primeiro o raciocínio (por que acontece), depois o diagnóstico (como reconhecer e diferenciar), depois a conduta (o que usar, quando e em que dose), e por fim a caixa **Como cai na prova**, com as pegadinhas mais prováveis em questões de caso clínico e de "quantas afirmativas estão corretas".

Tudo foi extraído das aulas. Quando uma informação veio de diretriz e não do material (porque a aula trazia a tabela apenas como imagem, que não pude ler), ela está marcada como **[complemento de diretriz]**. As abreviações aparecem por extenso na primeira vez em cada aula.

Lacunas declaradas. As aulas de Asma (degraus do GINA, tabelas de crise), IVAS (escore de Centor), Diarreias (tabelas de agentes e Plano ABC) e Meningite (tabela de líquor) tinham conteúdo em imagem. Onde completei, marquei. A pasta de provas antigas não abriu para a conta conectada; as questões do final seguem o formato que você descreveu, não o estilo exato da banca.

Plano de estudo: sexta, domingo e segunda

O princípio é simples: ler explicação uma vez, testar-se imediatamente, e revisar apenas o que errou. Leitura passiva repetida dá sensação de domínio sem gerar recuperação na hora da prova.

Dia	Bloco	Conteúdo	Tarefa ativa
Sexta	Manhã	Aulas 1, 2, 3	Refazer à mão o cálculo de amoxicilina e o "jeitinho SUS"
Sexta	Tarde	Aulas 4, 5, 6	Montar de memória a tabela de sinais de perigo e de internação
Sexta	Noite	Aula 7	Escrever o antibiótico empírico por faixa etária sem olhar
Domingo	Manhã	Aulas 8, 9, 10	Explicar em voz alta a diferença entre diarreia osmótica e secretora

Dia	Bloco	Conteúdo	Tarefa ativa
Domingo	Tarde	Aulas 11, 12, 13	Calcular uma estatura alvo e uma velocidade de crescimento
Domingo	Noite	Aula 15	Preencher em branco a tabela comparativa dos exantemas
Segunda	Manhã	Questões 1 a 30 cronometradas (60 min)	Corrigir pelo gabarito comentado
Segunda	Tarde	Reler só as seções das questões erradas	Refazer as erradas
Segunda	Noite	Mapa de medicamentos e caixas "Como cai na prova"	Dormir cedo; nada de conteúdo novo

Técnica para as questões de "quantas afirmativas estão corretas". Julgue cada afirmativa isoladamente como V ou F antes de olhar as alternativas, e escreva a letra ao lado. As afirmativas falsas costumam trocar um número (idade, dose, dias), inverter uma relação (aumenta por diminui) ou generalizar com "sempre" e "nunca". Desconfie dessas palavras.

Aula 1. Hemograma na pediatria

O hemograma infantil se lê sempre contra a faixa etária: o que é normal no recém-nascido é anormal no escolar. A aula recomenda triagem com 1 ano de idade com hemograma, PCR (proteína C reativa), ferro sérico e ferritina.

Série vermelha: como raciocinar

1. **Existe anemia?** Anemia é hemoglobina abaixo de 2 desvios padrão para a idade. Regra de conferência: hematócrito ≈ hemoglobina × 3.
2. **Qual o tamanho da hemácia?** VCM (volume corpuscular médio): abaixo de 80 é microcítica, 80 a 100 normocítica, acima de 100 macrocítica.
3. **As hemácias são iguais entre si?** RDW (índice de anisocitose) normal 10 a 15%; acima de 15% é anisocitose. Na ferropenia o RDW sobe **antes** de a hemoglobina e o VCM caírem, porque a medula começa a liberar células menores misturadas às antigas.
4. **A medula está respondendo?** Reticulócitos altos significam que a medula produz e a perda está na periferia (sangramento ou hemólise). Reticulócitos baixos significam defeito de produção (falta de ferro, aplasia, infiltração).

Anemia ferropriva

Por que acontece: baixa reserva ao nascer, crescimento rápido e dieta pobre em ferro (leite de vaca, introdução alimentar inadequada). **Pistas clínicas cobradas:** pica, pagofagia (comer gelo), pernas inquietas, palidez. **Laboratório:** microcitose, hipocromia, RDW alto, ferritina baixa, reticulócitos baixos.

Situação	Dose de ferro elementar	Quando e por quanto tempo
Profilaxia sem fator de risco	1 mg/kg/dia	Dos 6 meses aos 2 anos
Profilaxia com fator de risco (prematuro, baixo peso)	1 mg/kg/dia, até 4 mg/kg/dia no baixo peso	Dos 3 meses aos 2 anos
Tratamento	3 a 6 mg/kg/dia	3 a 6 meses; reavaliar com hemograma e reticulócitos em 30 a 45 dias

Detalhe de prova: não dar o ferro junto com leite ou fórmula, porque o cálcio reduz a absorção. A resposta esperada primeiro é a subida de reticulócitos; a ferritina é a última a normalizar, por isso o tratamento continua meses após a hemoglobina normalizar.

Série branca

- **Neutrofilia (acima de 7.000):** procure desvio à esquerda (formas jovens), que sugere infecção bacteriana. Causas não infecciosas, por demarginalização dos neutrófilos aderidos ao endotélio: adrenalina, convulsão, dor, corticoide e exercício.
- **Reação leucemoide:** leucócitos acima de 50.000 com desvio, mas com células **maduras** e reacionais. Causas: infecção bacteriana grave, tuberculose, brucelose, toxoplasmose, glomerulonefrite, artrite reumatoide, insuficiência hepática, cetoacidose diabética.
- **Leucemia linfoide aguda (LLA):** o que a diferencia da reação leucemoide é o acometimento das outras linhagens e a presença de **blastos**: anemia, plaquetopenia, leucocitose com blastos, hepatoesplenomegalia, dor óssea e equimoses.
- **Neutropenia:** leve 1.000 a 1.500; moderada 500 a 1.000; grave abaixo de 500. **Neutropenia febril é emergência** e se trata com cefepime.
- **Linfócitos atípicos:** pensar em vírus Epstein-Barr (mononucleose; acima de 20% é fortemente sugestivo, ver Aula 15).

Plaquetas

- **Trombocitose (acima de 450.000):** quase sempre reacional (infecção, inflamação, ferropenia), mediada pela trombopoetina. Lembre que na doença de Kawasaki a plaquetose surge na 3ª semana.
- **Trombocitopenia (abaixo de 150.000):** três mecanismos: produção diminuída, destruição aumentada ou sequestro (baço grande).
- **PTI (púrpura trombocitopênica imune):** criança previamente hígida, cerca de 3 semanas após infecção viral, com petequias e plaquetas baixas isoladas (sem anemia, sem blastos, sem visceromegalia). De 80 a 85% resolvem só com observação; corticoide ou imunoglobulina apenas se houver sangramento.
- **Plaquetopenia neonatal:** causas perinatais, infecções, CIVD (coagulação intravascular disseminada), PTI ou lúpus materno e causa isoimune.

> **Como cai na prova.** (1) RDW alto com hemoglobina ainda normal = ferropenia inicial. (2) Leucocitose acima de 50.000 com células maduras = leucemoide; com blastos e citopenias = LLA. (3) Plaquetopenia isolada pós-viral em criança bem = PTI; a conduta na maioria é observar. (4) Profilaxia de ferro sem risco começa aos 6 meses, não aos 3. (5) Neutropenia febril: cefepime, sem esperar cultura.

Aula 2. Antibioticoterapia e cálculo de doses

Em crianças abaixo de 7 anos usamos formas líquidas e toda dose é calculada em mg/kg/dia, depois dividida pelo número de tomadas. Acima de 30 kg, usa-se a dose de adulto (por exemplo, amoxicilina 500 mg de 8/8 h, que equivale a 10 mL da suspensão de 250 mg/5 mL).

Como calcular sem errar

A conta tem três passos: (1) dose diária = peso × mg/kg/dia; (2) dose por tomada = dose diária ÷ número de tomadas; (3) volume = dose por tomada ÷ concentração (mg/mL).

Exemplo. Criança de 15 kg, amoxicilina 50 mg/kg/dia de 8/8 h, suspensão 250 mg/5 mL (50 mg/mL). Dose diária 750 mg; por tomada 250 mg; volume 5 mL de 8/8 h.

Atalho da aula: volume por tomada = peso ÷ número de doses. Ele só funciona quando a concentração “encaixa” na dose (amoxicilina 250 mg/5 mL a 50 mg/kg/dia em 8/8 h divide por 3; em 12/12 h, por 2). Se a concentração ou a dose mudar, faça a conta completa.

Os quatro antibióticos da aula

Fármaco	Dose	Cobre	Usar em	Não usar em
Amoxicilina	50 a 100 mg/kg/dia, 8/8 ou 12/12 h; dose alta 80 a 100	Pneumococo, estreptococo do grupo A	Amigdalite, OMA, sinusite, PAC	Bactéria produtora de betalactamase
Amoxicilina com clavulanato	Mesma base de amoxicilina	Acrescenta S. aureus sensível, H. influenzae, Moraxella, E. coli, anaeróbios	Falha da amoxicilina, risco de resistência	Quando a amoxicilina isolada basta
Cefalexina (cefalosporina de 1ª geração)	50 a 100 mg/kg/dia, 6/6 ou 8/8 h	Gram-positivos, alguns gram-negativos urinários	Faringite (alergia leve), pele, ITU (infecção do trato urinário)	**OMA, sinusite, pneumonia**
Azitromicina	10 mg/kg/dia, 1 vez ao dia	Atípicos, B. pertussis, Chlamydia	PAC atípica, coqueluche, ISTs, alergia grave a penicilina	Primeira escolha em OMA ou sinusite

Por que a cefalexina falha em OMA e sinusite: ela não cobre bem o H. influenzae nem a Moraxella, que são justamente os agentes produtores de betalactamase dessas infecções.

Amoxicilina com clavulanato: o "jeitinho SUS"

O clavulanato é o responsável pela diarreia. Por isso, quando precisamos de dose alta de amoxicilina com proteção contra betalactamase, não aumentamos o clavulanato: mantemos cerca de 7,5 mg/kg/dia de clavulanato e completamos a amoxicilina com amoxicilina pura.

Apresentação	Amoxicilina/clavulanato por 5 mL	Proporção
Convencional (a do SUS)	250/62,5	4:1
ES	400/57	7:1

Apresentação	Amoxicilina/clavulanato por 5 mL	Proporção
BD	600/42,9	14:1

Montagem: cerca de 30 mg/kg/dia de amoxicilina vindos da amoxicilina com clavulanato (4:1) mais 50 a 70 mg/kg/dia vindos da amoxicilina pura. **Exemplo da aula, 12 kg:** 2,5 mL de amoxicilina com clavulanato mais 4 mL de amoxicilina, ambos de 8/8 h por 7 dias.

Azitromicina: farmacologia que cai

Macrolídeo bacteriostático que age na subunidade 50S do ribossomo, não deve ser dado junto de alimento e tem excreção fecal. **Vômito após a dose:** se imediato, repetir a dose inteira; aos 15 minutos, repetir metade; após 30 minutos, não repetir (já foi absorvida).

> **Como cai na prova.** (1) Cálculo de volume com suspensão de 250 mg/5 mL. (2) Cefalexina para OMA ou sinusite é afirmativa falsa. (3) Diarreia da amoxicilina com clavulanato vem do clavulanato. (4) Azitromicina é dose única diária de 10 mg/kg. (5) Acima de 30 kg, dose de adulto.

Aula 3. IVAS: amigdalite, otite média aguda e sinusite

As IVAS (infecções de vias aéreas superiores) são majoritariamente virais. A pergunta central de cada uma é a mesma: **quando a bactéria é provável o bastante para justificar antibiótico**, e qual antibiótico cobre os agentes daquela região.

Faringoamigdalite

Epidemiologia que decide a conduta: de 70 a 90% são virais. O estreptococo beta-hemolítico do grupo A (EBGA) responde por 20 a 30% dos casos entre 5 e 15 anos, e quase nunca causa amigdalite abaixo dos 3 anos.

Sugere bactéria (EBGA)	Sugere vírus
Início abrupto, febre alta	Início gradual
Linfonodos cervicais anteriores dolorosos	Tosse, coriza, rouquidão
Exsudato ou placas grandes	Conjuntivite, aftas, diarreia
Ausência de tosse e coriza	Idade abaixo de 3 anos

[complemento de diretriz] O escore de Centor modificado (McIsaac) soma 1 ponto para febre acima de 38 °C, ausência de tosse, adenopatia cervical anterior dolorosa, exsudato amigdaliano e idade de 3 a 14 anos (subtrai 1 ponto acima de 45 anos). Escores altos reforçam a indicação de teste ou tratamento.

Teste rápido: alta especificidade e baixa sensibilidade. Positivo, trate. Negativo, não descarta: faça cultura.

Tratamento e por que tratá-la: o objetivo principal é prevenir febre reumática.

Situação	Escolha
Primeira linha	Penicilina benzatina 50.000 UI/kg IM dose única (abaixo de 27 kg 600.000 UI; acima de 27 kg 1.200.000 UI) ou amoxicilina por 10 dias (penicilina V também serve)
Falha em 48 a 72 h	Amoxicilina com clavulanato por 10 dias
Alergia leve à penicilina	Cefalexina
Alergia grave	Clindamicina ou azitromicina (azitromicina por 5 dias)

Abscesso periamigdaliano: voz “de batata quente”, trismo, desvio da úvula. Conduta: drenagem pelo otorrinolaringologista mais amoxicilina com clavulanato ou clindamicina.

Amigdalite de repetição: 3 episódios em 6 meses ou 4 em 1 ano.

Otite média aguda (OMA)

Raciocínio: a tuba auditiva da criança pequena é curta e horizontal; uma IVAS viral obstrui a tuba e a secreção retida na orelha média se infecta. Pico entre 6 e 24 meses; rara abaixo de 6 meses. Agentes: vírus, pneumococo, H. influenzae e Moraxella. **O sinal mais confiável é o abaulamento da membrana timpânica.** A resistência do pneumococo ocorre por alteração das PBP (proteínas ligadoras de penicilina), e não por PBP2a (mecanismo do S. aureus resistente à oxacilina) nem por betalactamase; por isso se vence com **dose alta** de amoxicilina.

Antibiótico imediato	Observação por 48 a 72 h permitida
Abaixo de 6 meses (sempre)	Acima de 6 meses
Grave: febre de 39 °C ou mais, dor intensa, otorreia	Febre abaixo de 39 °C e dor leve

Antibiótico imediato	Observação por 48 a 72 h permitida
Abaixo de 2 anos com OMA bilateral	OMA unilateral sem otorreia
Toxemia, dor acima de 48 h, falha	Família com acesso garantido ao retorno
Sem acesso ao seguimento	

Linha	Escolha
1ª	Amoxicilina; dose alta se frequenta creche ou usou antibiótico recente
2ª	Amoxicilina com clavulanato; cefuroxima (alergia leve); clindamicina; levofloxacino
3ª	Ceftriaxona 50 mg/kg IM por 1 a 3 dias

Duração: acima de 2 anos, 5 a 7 dias; abaixo de 2 anos, 7 a 10 dias.

Sinusite bacteriana aguda

Desenvolvimento dos seios (explica a idade): etmoidais e maxilares já existem ao nascer; esfenoidal aos 5 anos; frontal aos 7 a 8 anos. Logo, sinusite frontal em lactente é impossível.

Agentes: pneumococo 30%, H. influenzae 30% (10 a 42% produzem betalactamase), Moraxella 10% (100% produzem betalactamase).

Diagnóstico clínico, por um de três padrões:

1. Persistente: sintomas por mais de 10 dias sem melhora.
2. Dupla piora: melhora inicial e depois nova piora.
3. Grave: febre acima de 39 °C com secreção purulenta por 3 a 4 dias.

Tomografia apenas em complicação, recorrência ou falha terapêutica; radiografia não é necessária.

Tratamento: amoxicilina é a primeira linha. Amoxicilina com clavulanato em dose alta se houver risco de resistência: idade abaixo de 2 ou acima de 65 anos, creche, antibiótico ou internação recentes, comorbidade, imunossupressão. Em crianças, 10 a 14 dias. Evitar macrolídeos (alta resistência do pneumococo).

> **Como cai na prova.** (1) Amigdalite com placas em criança de 2 anos: pense em vírus. (2) Teste rápido negativo não exclui; peça cultura. (3) Penicilina benzatina: corte em 27 kg. (4) OMA abaixo de 6 meses sempre recebe antibiótico. (5) Abaulamento é o achado mais específico. (6) Resistência do pneumococo é por PBP alterada, vencida com dose alta. (7) Sinusite é diagnóstico clínico: 10 dias, dupla piora ou grave.

Aula 4. Pneumonia adquirida na comunidade (PAC)

Na criança, o sinal mais sensível de pneumonia é a **taquipneia**, não a ausculta. Por isso a OMS (Organização Mundial da Saúde) define o diagnóstico de triagem pela frequência respiratória (FR) e a gravidade pelos sinais de perigo.

Taquipneia pela OMS

Idade	FR que define taquipneia
Abaixo de 2 meses	60 ou mais (já é sinal de perigo)
2 a 12 meses	50 ou mais
12 a 60 meses	40 ou mais

Sinais de perigo e gravidade

Abaixo de 2 meses: FR de 60 ou mais, tiragem subcostal, febre ou hipotermia, recusa de 3 mamadas, sibilância ou estridor, sensório alterado. Qualquer um interna.

De 2 meses a 5 anos: tiragem, estridor, recusa de líquidos, convulsão ou alteração do sensório, vômitos incoercíveis.

PAC grave: temperatura de 38,5 °C ou mais, FR acima de 70 no lactente ou acima de 50 na criança maior, gemência, batimento de asa do nariz (BAN), apneia, cianose, saturação abaixo de 90%, tempo de enchimento capilar de 2 s ou mais.

Indicações de internação: PAC grave, tiragem, incapacidade de beber, cianose, problema social, desidratação, comorbidade, impossibilidade de via oral, e idade de 3 a 6 meses (exceto se viral e em bom estado geral).

Agente por idade e por quadro

Quadro	Agente	Pistas
Neonatal precoce (abaixo de 3 dias)	Estreptococo do grupo B, bacilos gram-negativos, Listeria	Adquirido no canal de parto
Neonatal tardia	S. aureus, S. epidermidis, gram-negativos	Ambiente hospitalar
Pneumonia afebril do lactente	Chlamydia trachomatis	1 a 3 meses, **sem febre**, conjuntivite prévia, eosinofilia; tratar com azitromicina ou claritromicina
PAC típica	Pneumococo, H. influenzae, Moraxella	Febre alta, PCR muito elevada, consolidação com broncograma aéreo
PAC atípica (acima de 5 anos)	Mycoplasma pneumoniae	Quadro arrastado, padrão intersticial, leucócitos normais; IgM em 7 a 10 dias, IgG subindo 4 vezes

Notas: a pesquisa de antígeno pelo látex continua válida até 5 dias após início do antibiótico. A vacina pneumocócica 10-valente não cobre os sorotipos 19A e 3.

Tratamento: quando usar qual

Cenário	Escolha
Ambulatorial típica	Amoxicilina (dose alta se risco de resistência) por 5 a 7 dias, ou 3 a 5 dias após a melhora; reavaliar em 48 a 72 h
Ambulatorial atípica	Azitromicina por 5 dias
Internado abaixo de 2 meses, precoce	Ampicilina mais gentamicina
Internado abaixo de 2 meses, tardia	Oxacilina mais gentamicina
Internado a partir de 2 meses	Ampicilina (ou penicilina cristalina) endovenosa
Suspeita de S. aureus	Oxacilina
Alternativas	Macrolídeo (atípico); amoxicilina com clavulanato

Cenário	Escolha
Com derrame pleural	Ampicilina ou penicilina cristalina; amoxicilina com clavulanato; ceftriaxona mais oxacilina

Derrame pleural parapneumônico

O derrame evolui em fases, e a conduta depende da fase porque, quanto mais organizado, menos o antibiótico sozinho alcança o espaço pleural.

Fase	Tempo	Conduta
Exsudativa	24 a 72 h	Antibiótico apenas
Fibrinopurulenta	7 a 10 dias	Drenagem, videotoracoscopia (VATS) ou fibrinolítico
Organização	2 a 4 semanas	Decorticação

Imagem: radiografia em decúbito lateral detecta acima de 50 mL; ultrassonografia detecta de 5 a 50 mL.

Drenar se: pus, bactéria no Gram ou cultura, pH abaixo de 7,1, glicose abaixo de 40 mg/dL ou DHL (desidrogenase lática) acima de 1.000. Sem melhora em 48 a 72 h após drenagem: VATS ou alteplase.

> **Como cai na prova.** (1) Lactente de 8 meses com FR 52 tem taquipneia; com 14 meses e FR 42 também. (2) Lactente de 2 meses, afebril, tosse, conjuntivite e eosinofilia: Chlamydia, azitromicina. (3) Escolar com quadro arrastado e intersticial: Mycoplasma, azitromicina. (4) Ambulatorial típica: amoxicilina, nunca cefalexina. (5) Derrame com pH 7,0 ou glicose 30: drenar.

Aula 5. Asma

Asma é doença inflamatória crônica das vias aéreas com hiper-reatividade brônquica e obstrução variável e reversível. Entender isso explica o tratamento: o **corticoide inalatório trata a inflamação (controle)** e o **broncodilatador trata o broncoespasmo (alívio)**. Faz parte da marcha atópica (dermatite atópica, rinite, asma).

Diagnóstico

Acima de 5 anos: clínica compatível mais espirometria, que deve ser feita **antes** de iniciar o tratamento, mostrando obstrução com resposta ao broncodilatador.

Abaixo de 5 anos: diagnóstico clínico, porque a criança não colabora com a espirometria. Sustentam o diagnóstico: sibilância recorrente, tosse ou chiado ao rir ou chorar, ausência de outra explicação e resposta ao broncodilatador ou ao corticoide inalatório.

Pouco provável que seja asma: tosse isolada, expectoração crônica, ruídos inspiratórios (estridor sugere via aérea alta).

Diagnósticos diferenciais: fibrose cística, bronquiectasia, discinesia ciliar, corpo estranho, displasia broncopulmonar, cardiopatia, tuberculose, traqueomalácia, doença do refluxo gastroesofágico.

Avaliação do controle (últimas 4 semanas)

[complemento de diretriz, GINA] Quatro perguntas: sintomas diurnos mais de 2 vezes por semana; despertar noturno por asma; uso de broncodilatador de alívio mais de 2 vezes por semana; limitação de atividade. Nenhuma: controlada. Uma ou duas: parcialmente controlada. Três ou quatro: não controlada.

Tratamento de manutenção

Da aula: o corticoide inalatório (CI) é a base do tratamento; efeitos adversos locais são disfonia e candidíase oral, prevenidos lavando a boca após o uso. O montelucaste é o único antagonista de leucotrienos aprovado abaixo de 12 anos. A associação CI com LABA (beta-2 agonista de longa ação) é necessária em 3 a 10% dos pacientes. Referência: GINA 2025.

[complemento de diretriz, GINA, degraus resumidos]

Degrau	6 a 11 anos	5 anos ou menos
1	CI em dose baixa sempre que usar o broncodilatador de alívio	Broncodilatador de alívio; curso de CI nas viroses
2	CI em dose baixa diária (alternativa: montelucaste)	CI em dose baixa diária (alternativa: montelucaste)
3	CI dose baixa com LABA, ou CI dose média	CI em dose dobrada (“dose baixa dobrada”)
4	CI dose média com LABA; encaminhar ao especialista	Manter e encaminhar ao especialista
5	Fenótipo e biológicos (especialista)	Especialista

Crise asmática: o que usar e quando

Medicamento	Quando	Detalhe que cai
Salbutamol (beta-2 de curta ação)	Toda crise	Spray com espaçador na crise leve a moderada; nebulização na grave
Brometo de ipratrópio	Crise moderada a grave, junto do salbutamol na sala de emergência	Reduz internação; **sem benefício depois de internado**
Sulfato de magnésio	Crise grave sem resposta inicial	25 a 75 mg/kg (máximo 2 g) endovenoso em 20 a 30 min
Corticoide sistêmico **[complemento]**	Crise moderada a grave	Prednisolona 1 a 2 mg/kg/dia (máx. 40 mg) por 3 a 5 dias
Oxigênio **[complemento]**	Saturação baixa	Alvo de 94 a 98%

A aula cita o escore PASS para avaliar gravidade da crise acima de 2 anos; a tabela estava em imagem e não pôde ser lida. Sinais clássicos de crise grave **[complemento]**: fala apenas palavras, agitação ou sonolência, uso intenso de musculatura acessória, saturação abaixo de 90%, tórax silencioso.

> **Como cai na prova.** (1) Espirometria antes do tratamento. (2) Abaixo de 5 anos o diagnóstico é clínico. (3) Montelucaste é o único antileucotrieno abaixo de 12 anos. (4) Ipratrópio só no pronto atendimento; não ajuda no internado. (5) Magnésio: dose máxima 2 g. (6) Candidíase oral pelo CI previne-se lavando a boca. (7) Controle avalia as últimas 4 semanas.

Aula 6. Bronquiolite viral aguda e coqueluche

Bronquiolite viral aguda

Definição operacional: primeiro episódio de sibilância em criança abaixo de 2 anos, desencadeado por vírus. O VSR (vírus sincicial respiratório) causa 50 a 80% dos casos, com pico no outono. Se é o segundo ou terceiro episódio de chiado, pense em lactente sibilante ou asma, não em bronquiolite.

Mecanismo: o vírus necrosa o epitélio dos bronquíolos; muco, restos celulares e edema obstruem vias aéreas muito finas, gerando aprisionamento de ar (hiperinsuflação) e atelectasias. Como não há broncoespasmo verdadeiro como na asma, **broncodilatador e**

corticoide não funcionam.

Evolução típica:

1. Dias 1 a 3: febre baixa e coriza.
2. Dias 3 a 5: taquidispneia e sibilância (pico de gravidade).
3. Duração total de 2 a 3 semanas (a tosse persiste).

Diagnóstico clínico. Radiografia só se dúvida: infiltrado peribrônquico, hiperinsuflação, atelectasia.

Internar se: apneia, toxemia, FR acima de 70, desidratação ou recusa alimentar, fatores de risco (prematuridade, idade abaixo de 3 meses, cardiopatia, pneumopatia, imunodeficiência **[fatores listados como complemento; a tabela estava em imagem]**). Bronquiolite grave é notificada como SRAG (síndrome respiratória aguda grave).

Recomendado	Não recomendado
Oxigênio se saturação abaixo de 92%	Corticoide
Lavagem nasal e aspiração	Adrenalina
Hidratação	Salina hipertônica
Cânula nasal de alto fluxo	Fisioterapia respiratória
Broncodilatador apenas como teste terapêutico (suspender se não houver resposta)	Antivirais

Prevenção: quem recebe o quê

Estratégia	Quem	Efeito
Vacina materna (Abrysvo)	Gestante de 32 a 36 semanas (no SUS, 28 a 36)	Proteção de 82% abaixo de 3 meses e 69% abaixo de 6 meses
Nirsevimabe	Dose única; abaixo de 1 ano, ou abaixo de 2 anos com fator de risco	Anticorpo monoclonal de longa duração
Palivizumabe	Grupos de risco	**Apenas profilaxia**, nunca tratamento

Coqueluche

Agente: Bordetella pertussis. Incubação de 5 a 10 dias. Transmite de 5 dias antes até 3 semanas após o início dos paroxismos.

Fase	Duração	Quadro	Por que importa
Catarral	1 a 2 semanas	Parece resfriado	**Mais transmissível**; antibiótico aqui encurta a doença
Paroxística	2 a 6 semanas	Acessos de tosse, guincho inspiratório, vômitos pós-tosse, apneia	Antibiótico já não muda o curso, mas reduz transmissão
Convalescença	2 a 6 meses	Tosse residual	Antibiótico não indicado

Abaixo de 6 meses: não há guincho; a doença se manifesta por **apneia, cianose e bradicardia**. É a faixa de maior letalidade (cerca de 1% abaixo de 2 meses).

Laboratório: leucocitose com **linfocitose** (a toxina pertussis impede a saída dos linfócitos do sangue). Radiografia com “coração felpudo”.

Exame	Janela útil
Cultura	Até 2 semanas
PCR (reação em cadeia da polimerase)	0 a 4 semanas
Sorologia	2 a 12 semanas

Tratamento: azitromicina por 5 dias; fenobarbital se convulsão. **Complicação mais comum:** pneumonia (22%). **Isolamento:** precaução para gotículas por 3 semanas, ou até 5 dias de antibiótico.

Quimioprofilaxia (azitromicina 5 dias) para contatos domiciliares e para contatos que sejam: abaixo de 1 ano, gestantes, imunodeficientes, pneumopatas, pessoas que convivem com alto risco e profissionais que trabalham com crianças.

Vacinação: 2, 4 e 6 meses, reforços aos 15 meses e 4 anos; dTpa na gestante a partir de 20 semanas, **em toda gestação**.

> **Como cai na prova.** (1) Primeiro chiado, abaixo de 2 anos, outono: bronquiolite; segundo chiado não é bronquiolite. (2) Afirmativas que indicam corticoide, salina hipertônica ou fisioterapia são falsas. (3) Palivizumabe não trata. (4) Lactente de 2 meses com apneias e cianose após tosse, sem guincho: coqueluche. (5) Linfocitose importante com tosse paroxística: coqueluche. (6) Antibiótico na convalescença: falso. (7) dTpa em toda gestação.

Aula 7. Meningoencefalites

A conduta inteira gira em torno de três decisões: (1) qual agente é provável para aquela idade, (2) o líquor é bacteriano, viral ou tuberculoso, (3) quem precisa de quimioprofilaxia.

Quadro clínico

Criança maior: febre, cefaleia, vômitos, rigidez de nuca, sinais de Kernig e Brudzinski. **Lactente:** sinais menos específicos; fontanela abaulada em 20 a 30% e convulsões em 20 a 50%. Hemoculturas são positivas em 80 a 90% das meningites bacterianas.

Meningococcemia: 15 a 20% são fulminantes, com síndrome de Waterhouse-Friderichsen (hemorragia adrenal) e letalidade de cerca de 40% (ver Aula 15).

Agente por idade

Idade	Agentes	Empírico
Recém-nascido	E. coli, estreptococo do grupo B, Listeria	Ampicilina mais gentamicina (ou ampicilina mais cefotaxima)
1 a 3 meses	Os neonatais mais pneumococo, meningococo, H. influenzae b	Cefotaxima ou ceftriaxona (com ampicilina se Listeria possível)
3 meses a 5 anos	Meningococo e pneumococo	Ceftriaxona ou cefotaxima
Acima de 5 anos	Pneumococo e meningococo	Ceftriaxona ou cefotaxima
Válvula de derivação (DVP)	S. epidermidis, S. aureus	Cobertura estafilocócica

Por que a ampicilina no recém-nascido: **Listeria é naturalmente resistente às cefalosporinas**. Por que não ceftriaxona abaixo de 28 dias: ela desloca a bilirrubina da albumina (risco de kernicterus) e precipita com cálcio. Se houver suspeita de pneumococo resistente, acrescentar vancomicina.

Líquor: o diferencial que mais cai

Parâmetro	Bacteriana	Viral	Tuberculosa
Células	Muito elevadas (frequentemente acima de 200, muitas vezes acima de 1.000)	Moderadamente elevadas	Moderadamente elevadas

Parâmetro	Bacteriana	Viral	Tuberculosa
Predomínio	Neutrófilos	Linfócitos	Linfócitos
Glicose	Baixa	Normal	**Muito baixa**
Proteína	Alta	Normal ou pouco alta	Muito alta
Pista extra	Gram positivo	Enterovírus no verão	Paralisia de nervos cranianos, evolução arrastada

Gram: cocos gram-positivos aos pares = pneumococo; diplococos gram-negativos = meningococo; cocobacilos gram-negativos = H. influenzae; bacilos gram-positivos = Listeria. **Cultura é o padrão-ouro.**

Punção traumática: descontar 1 leucócito para cada 500 hemácias; a proteína sobe 1 a 1,5 mg/dL a cada 1.000 hemácias. Exemplo da aula: 23 leucócitos com 9.000 hemácias; 23 menos 9.000/500 (18) = 5 leucócitos reais.

Punção lombar: entre L3 e L4. Tomografia antes se houver déficit focal. Contraindicações: instabilidade hemodinâmica, infecção de pele no local, plaquetas abaixo de 50.000, mielomeningocele. Pressão de perfusão cerebral = pressão arterial média menos pressão intracraniana; abaixo de 40 é grave.

Dexametasona

0,15 mg/kg de 6/6 h por 2 a 4 dias, **antes ou junto da primeira dose de antibiótico**. Objetivo: reduzir a inflamação desencadeada pela lise bacteriana e proteger a audição. Benefício comprovado em H. influenzae e pneumococo.

Duração do antibiótico

Agente	Dias
Meningococo	5 a 7
H. influenzae b	7 a 10
Pneumococo	10 a 14
Estafilococo	14
Listeria	21
Gram-negativos	21 (3 semanas)

Agente	Dias
Desconhecido	Recém-nascido 14; lactente 10

Mnemônico: “Meningo rápido, Hib dez, Pneumo duas semanas, Listeria três.”

Quimioprofilaxia

Agente	Quem recebe	Esquema
Meningococo	Contatos íntimos e domiciliares (risco 500 a 800 vezes maior); profissional de saúde só se intubou ou aspirou sem EPI	Rifampicina 12/12 h por 2 dias, ou ceftriaxona dose única, ou ciprofloxacino dose única
H. influenzae b	Contatos domiciliares quando há criança abaixo de 4 anos não vacinada ou imunocomprometida; creche com 2 ou mais casos em 60 dias	Rifampicina 1 vez ao dia por 4 dias

Meningococo: incubação de 2 a 10 dias; transmite até 24 h após início do antibiótico eficaz.

Vacinas

Meningocócica C aos 3 e 5 meses; ACWY aos 12 meses e dos 11 aos 14 anos; pentavalente (inclui Hib) aos 2, 4 e 6 meses; pneumocócica 10-valente aos 2, 4 e 12 meses.

Meningoencefalites virais

Enterovírus: a causa mais comum, transmissão fecal-oral, tratamento de suporte. **Herpes simples:** encefalite com acometimento do lobo temporal (alteração de comportamento, convulsão focal); tratar com aciclovir endovenoso sem esperar confirmação.

> **Como cai na prova.** (1) Líquor linfocítico com glicose muito baixa e paralisia de nervo craniano: tuberculose. (2) Ceftriaxona no recém-nascido: falso. (3) Ampicilina no esquema neonatal cobre Listeria. (4) Dexametasona depois do antibiótico já iniciado perde o sentido. (5) Profissional de saúde só recebe profilaxia se exposto sem EPI a secreções. (6) Diplococo gram-negativo: meningococo. (7) Correção de punção traumática: 1 leucócito por 500 hemácias.

Aula 8. Diarreias agudas e crônicas

Definições de tempo (caem muito): diarreia aguda tem 3 ou mais evacuações líquidas por dia por menos de 14 dias; persistente, de 14 a 30 dias; crônica, acima de 30 dias.

Os três mecanismos da diarreia aguda

Mecanismo	Como acontece	Exemplo	Pista que diferencia
Osmótico	Vírus lesa o enterócito, falta lactase, a lactose não absorvida puxa água	Rotavírus	**Melhora com jejum**; fezes ácidas (pH abaixo de 5,5)
Secretor	Toxina ativa AMPc ou GMPc e o enterócito secreta cloro e água	E. coli enterotoxigênica, cólera	**Persiste em jejum**; grande volume
Inflamatório (invasivo)	Bactéria invade a mucosa	Shigella, Campylobacter	**Disenteria** (sangue, muco), febre, leucócitos fecais

Rotavírus: 40% das diarreias graves, entre 6 e 24 meses; o vômito precede a diarreia em 80 a 90% dos casos.

Quando pedir exames: sangue nas fezes, idade abaixo de 4 meses ou imunossupressão. pH fecal abaixo de 5,5 indica intolerância a carboidrato; leucócitos fecais indicam processo invasivo.

Tratamento da diarreia aguda

1. Soro de reidratação oral de baixa osmolaridade.
2. **Manter a alimentação** (não suspender leite materno nem dieta).
3. Zinco por 10 dias: 10 mg/dia abaixo de 6 meses; 20 mg/dia a partir de 6 meses.
4. Ondansetrona para vômitos; probióticos e racecadotrila como adjuvantes.
5. **Antibiótico só se:** quadro grave, disenteria, imunossupressão ou idade abaixo de 4 meses.

[complemento de diretriz, Ministério da Saúde 2023; a aula cita o Plano ABC atualizado, mas a tabela estava em imagem]

Plano	Estado de hidratação	Conduta
A	Sem desidratação (alerta, olhos normais, bebe normal, prega volta rápido)	Domicílio: SRO após cada evacuação, zinco, alimentação, sinais de alarme
B	Alguma desidratação (irritado, olhos fundos, sedento, prega volta lentamente)	Na unidade: SRO 50 a 100 mL/kg em 4 a 6 h, reavaliando
C	Desidratação grave (letárgico, bebe mal, prega muito lenta acima de 2 s, pulso fraco)	Endovenosa: abaixo de 1 ano, 30 mL/kg em 1 h e 70 mL/kg em 5 h; a partir de 1 ano, 30 mL/kg em 30 min e 70 mL/kg em 2 h 30 min (soro fisiológico ou Ringer lactato)

[complemento] Antibiótico por agente: Shigella, ciprofloxacino (ceftriaxona se grave); cólera, azitromicina; giardíase e amebíase, metronidazol.

Vacina rotavírus (VORH): dose 1 aos 2 meses (limite de 1 mês e 15 dias a 11 meses e 29 dias); dose 2 aos 4 meses (limite de 3 meses e 15 dias a 23 meses e 29 dias). Fora dessas janelas não se aplica, pelo risco de invaginação intestinal.

Diarreia crônica: como diferenciar as causas

Causa	Idade e quadro	Exame que confirma
Doença celíaca	1 a 3 anos, após introdução do glúten; distensão, baixo ganho de peso	Anti-transglutaminase e antiendomísio (sensibilidade acima de 95%)
Alergia à proteína do leite de vaca (APLV)	Lactente; pode ter sangue nas fezes	Dieta de exclusão por 8 semanas e reintrodução
Intolerância à lactose	Escolar; diarreia osmótica, distensão, gases	Fezes ácidas, melhora com retirada
Doença inflamatória intestinal	10 a 15% começam antes dos 10 anos	p-ANCA na retocolite ulcerativa; ASCA na doença de Crohn; calprotectina alta
Fibrose cística	Esteatorreia, infecções respiratórias	Esteatócrito; quimiotripsina fecal baixa (insuficiência pancreática)
Doença de Hirschsprung	Constipação desde o nascimento, enterocolite	Biópsia retal

Marcadores fecais: alfa-1-antitripsina alta indica perda proteica intestinal; quimiotripsina baixa indica insuficiência pancreática; calprotectina alta indica inflamação da mucosa.

Estado nutricional: albumina abaixo de 3 g/dL indica desnutrição moderada a grave. O peso cai antes da estatura (a estatura só se compromete na desnutrição crônica).

> **Como cai na prova.** (1) Diarreia que persiste em jejum: secretora. (2) Vômitos antes da diarreia em lactente de 1 ano: rotavírus. (3) Zinco 10 mg abaixo de 6 meses e 20 mg acima, por 10 dias. (4) Suspender alimentação: falso. (5) Antibiótico de rotina: falso. (6) Fezes ácidas: má absorção de carboidrato. (7) APLV no lactente, lactose no escolar. (8) Rotavírus fora da idade limite: não vacinar.

Aula 9. Desenvolvimento, TEA e TDAH

Vigilância do desenvolvimento

Avalia-se marcos do desenvolvimento, perímetro cefálico e testes de triagem. No **Denver II**, a faixa branca representa 25 a 75% das crianças que já realizam a tarefa e a faixa cinza, 75 a 90%. Falhar numa tarefa que 90% das crianças da idade já fazem é atraso.

Para onde encaminhar, conforme o domínio atrasado:

Domínio	Encaminhamento
Motor grosso	Fisioterapia
Motor fino adaptativo	Terapia ocupacional
Pessoal-social	Psicologia e terapia ocupacional
Linguagem	Fonoaudiologia

TEA (transtorno do espectro autista)

Epidemiologia: prevalência de 1 em 31; 30% têm deficiência intelectual; diagnóstico médio aos 4 a 5 anos, embora sinais possam ser vistos antes dos 2 anos.

Núcleo diagnóstico [estrutura do DSM-5, complemento]: déficit persistente na comunicação e interação social mais padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, presentes desde o início do desenvolvimento.

M-CHAT (triagem): aplicado dos 18 aos 24 meses, com 20 itens. Em geral a resposta "não" indica risco, **exceto nos itens 2, 5 e 12, em que "sim" indica risco**.

Pontuação (segundo a aula)	Risco	Conduta
0 a 2	Baixo	Reavaliar se surgir preocupação
3 a 8	Moderado	Entrevista de seguimento
9 ou mais	Alto	Encaminhar para diagnóstico e intervenção

Observação: a versão oficial do M-CHAT-R/F usa os cortes 0 a 2, 3 a 7 e 8 a 20. Como a prova vem do professor, priorize os números da aula, mas não marque uma afirmativa como falsa só porque usa os cortes oficiais.

Níveis de suporte: 1 (exige suporte), 2 (exige suporte substancial), 3 (exige suporte muito substancial).

Tratamento: a base é intervenção comportamental e terapias. Medicamentos tratam sintomas associados, não o autismo: melatonina para insônia; risperidona ou aripiprazol para irritabilidade e agressividade (risperidona é off-label abaixo de 18 anos segundo a aula). **Sem evidência:** dieta sem glúten ou sem caseína, ômega-3, transplante fecal, ozonioterapia, oxigênio hiperbárico.

TDAH (transtorno do déficit de atenção com hiperatividade)

Critérios (cada número cai em prova):

- 6 ou mais sintomas de desatenção e/ou de hiperatividade-impulsividade.
- Por 6 meses ou mais.
- Início antes dos 12 anos.
- Em 2 ou mais ambientes (casa e escola, por exemplo).
- Prejuízo funcional.

Proporção entre sexos de 1 menina para 2,4 meninos. **SNAP-IV:** mais de 6 respostas “bastante” ou “demais” nos itens 1 a 9 indica desatenção; nos itens 10 a 18, hiperatividade-impulsividade.

Mnemônico “6, 6, 12, 2”: seis sintomas, seis meses, antes dos doze anos, dois ambientes.

Tratamento	Lugar	Detalhe
Terapia cognitivo-comportamental	Base de todo tratamento	Orientação aos pais e escola
Metilfenidato (liberação imediata e prolongada)	1ª linha	Estimulante
Lisdexanfetamina	1ª linha	Estimulante, longa duração
Atomoxetina	2ª linha	Não estimulante; começa a agir em 2 a 4 semanas, efeito pleno em 6 a 8

Não suspender a medicação em fins de semana ou férias. A aula traz um quadro de “outras medicações” em imagem que não pôde ser lido.

> **Como cai na prova.** (1) M-CHAT: 18 a 24 meses, 20 itens, itens 2, 5 e 12 invertidos. (2) TDAH exige início antes dos 12 anos e 2 ambientes. (3) Dieta sem glúten para autismo: falso. (4) Atomoxetina não é estimulante e demora semanas. (5) Atraso de linguagem vai para fonoaudiologia; motor grosso para fisioterapia. (6) Risperidona trata irritabilidade, não o núcleo do autismo.

Aula 10. Adolescência

Definições de idade: OMS, de 10 a 19 anos; ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), de 12 a 18 anos. A consulta do adolescente tem como pilar o **sigilo**, que só se quebra diante de risco à vida (do próprio ou de terceiros), como ideação suicida, abuso ou gravidez de

risco **[critérios de quebra: complemento]**. A aula descreve os 10 elementos da Síndrome da Adolescência Normal (busca de identidade, tendência grupal, necessidade de fantasiar, crises religiosas, deslocalização temporal, evolução sexual, atitude social reivindicatória, contradições de conduta, separação progressiva dos pais, flutuações de humor) **[lista de Aberastury e Knobel; nomes dos itens como complemento]**.

Ciclo menstrual e dismenorreia

Nos 2 primeiros anos após a menarca, cerca de 50% dos ciclos são anovulatórios, porque o eixo hipotálamo-hipófise-ovário ainda amadurece; irregularidade nessa fase é esperada. Mais de 90 dias sem menstruar exige investigação.

Dismenorreia primária surge 2 a 3 anos após a menarca, quando os ciclos se tornam ovulatórios (a progesterona pós-ovulação aumenta prostaglandinas no endométrio). Por isso o tratamento é antiprostaglandínico:

1. 1ª linha: AINE (anti-inflamatório não esteroide), com resposta em 80%. Ácido mefenâmico 500 mg 3 a 4 vezes ao dia ou ibuprofeno 400 mg 4 vezes ao dia.
2. 2ª linha: anticoncepcional oral combinado (bloqueia a ovulação).

Contracepção

Métodos de longa duração, como o implante, são preferidos. Métodos só de progestágeno (especialmente o injetável trimestral) preocupam pela redução de massa óssea numa fase de pico de formação óssea. Injetável **mensal** é combinado; injetável **trimestral** é só progestágeno.

Ginecomastia

Diferenciar de **lipomastia** (acúmulo de gordura sem tecido glandular, comum na obesidade). Ginecomastia puberal é frequente e geralmente regride. Investigação quando necessária: beta-hCG, LH, testosterona e estradiol. Tratamento: tamoxifeno; cirurgia se acima de 5 cm (Tanner III e IV), impacto psicológico grave ou persistência após os 15 anos.

Saúde mental e comportamento

- Bullying; PIMU (problemas relacionados ao uso de internet e mídias); FOMO (medo de ficar de fora) e FOBLO (medo de ficar sem bateria ou sem conexão).
- **Gaming disorder (CID-11):** padrão por 12 meses que preenche **todos** os critérios (perda de controle, prioridade sobre outras atividades, manutenção apesar de prejuízo).
- **Automutilação:** pico entre 13 e 15 anos.

- **Resolução CFM 2.427/2025:** proíbe bloqueadores puberais para incongruência de gênero e veda terapia hormonal cruzada abaixo de 18 anos.

Cálcio e vitamina D

Nutriente	Recomendação	Detalhe
Cálcio	1.300 mg/dia	Citrato longe das refeições; carbonato junto das refeições (precisa de acidez); suplemento de 500 mg
Vitamina D, prevenção	600 UI/dia (1.200 UI em grupos de risco)	
Vitamina D, tratamento	6.000 UI/dia por 12 semanas ou 50.000 UI/semana por 8 semanas	

> **Como cai na prova.** (1) OMS 10 a 19, ECA 12 a 18. (2) Ciclos irregulares nos 2 primeiros anos são normais. (3) Dismenorreia: AINE primeiro. (4) Carbonato de cálcio com refeição; citrato longe. (5) Gaming disorder exige 12 meses. (6) Injetável trimestral prejudica massa óssea.

Aula 11. Hepatoesplenomegalia

Quando o fígado e o baço são realmente grandes

Órgão	Limite normal
Fígado, recém-nascido e lactente	Até 2 a 3 cm abaixo do rebordo costal direito
Fígado, acima de 2 anos	Até 2 cm
Fígado, acima de 10 anos	Não palpável
Baço	A ponta pode ser palpável até os 10 anos; baço claramente palpável tem pelo menos o dobro do tamanho normal. Percussão do espaço de Traube ajuda

Esplenomegalia maciça: calazar, leucemia mieloide crônica, linfoma.

Pensar por mecanismo

O órgão cresce por cinco razões: infecção ou inflamação, depósito, infiltração neoplásica, congestão e hematopoiese extramedular ou hemólise **[organização por mecanismo: complemento didático]**. Cada doença da aula cai em uma delas.

Doença	Mecanismo	Pistas que fecham o diagnóstico	Conduta ou exame-chave
Infecções congênitas (TORCHS)	Infecção	Recém-nascido com hepatoesplenomegalia, petequias, icterícia	Sorologias materna e do RN
Citomegalovirose congênita	Infecção	**Calcificações periventriculares** (na toxoplasmose são difusas), microcefalia, surdez	PCR na urina
Calazar (leishmaniose visceral)	Infecção com infiltração do sistema reticuloendotelial	Febre prolongada, esplenomegalia volumosa, **pancitopenia**, hipergamaglobulinemia	Amastigotas no mielograma; anfotericina B lipossomal
Doença de Gaucher	Depósito (deficiência de glicocerebrosidase)	Ascendência judaica, esplenomegalia, citopenias, dor óssea	Dosagem enzimática
Doença de Wilson	Depósito de cobre	Hepatopatia com sinais neurológicos ou psiquiátricos	**Anéis de Kayser-Fleischer**
Síndrome de Reye	Lesão mitocondrial hepática	Mais em meninos; após virose com uso de AAS; encefalopatia	Evitar AAS em viroses **[associação com AAS: complemento]**
Leucemia (LLA)	Infiltração	Citopenias, blastos, dor óssea, DHL alta	Mielograma

Nota da aula: a ceftriaxona compete com a bilirrubina pela albumina, razão pela qual é evitada no recém-nascido ictérico.

Os quatro casos da aula, em uma linha cada

1. **Gaucher:** criança de origem judaica com esplenomegalia e citopenias, sem febre.

2. **CMV congênito:** recém-nascido com hepatoesplenomegalia, microcefalia e calcificações periventriculares; confirmar com PCR na urina.
3. **Calazar:** criança de área endêmica com febre prolongada, baço enorme, pancitopenia e globulinas altas.
4. **LLA:** palidez, petequias, dor óssea, hepatoesplenomegalia e blastos.

> **Como cai na prova.** (1) Calcificações periventriculares = CMV; difusas = toxoplasmose. (2) Pancitopenia com hipergamaglobulinemia e febre = calazar. (3) Kayser-Fleischer = Wilson. (4) Baço palpável já tem o dobro do normal. (5) Fígado palpável acima de 10 anos é anormal.

Aula 12. Baixa estatura

Definição: estatura abaixo do percentil 3 ou abaixo de 2 desvios padrão (DP) para idade e sexo. Abaixo de 3 anos mede-se o comprimento deitado. A pergunta que separa o normal do patológico não é “qual a altura”, mas **“a criança cresce na velocidade certa?”**

As três ferramentas

1. Velocidade de crescimento (VC): diferença de estatura entre duas medidas dividida pelo intervalo em anos. Exemplo: cresceu 2 cm em 6 meses, VC = 2 ÷ 0,5 = 4 cm/ano. No escolar o esperado é 5 a 7 cm/ano, então 4 cm/ano é baixa. No estirão puberal o pico é de 11 cm/ano nos meninos e 9 cm/ano nas meninas.

2. Estatura alvo familiar (potencial genético):

$$\text{Menino} = \frac{\text{altura do pai} + \text{altura da mãe} + 13}{2} \qquad \text{Menina} = \frac{\text{altura do pai} - 13 + \text{altura da mãe}}{2}$$

O resultado tem margem de mais ou menos 5 cm. Exemplo: pai 175 cm, mãe 160 cm; menino (175 + 160 + 13)/2 = 174 cm (169 a 179); menina (175 − 13 + 160)/2 = 161 cm.

3. Idade óssea (IO): radiografia da mão e punho esquerdos. Mostra quanto crescimento ainda resta.

O diferencial principal

	Baixa estatura familiar	Atraso constitucional	Patológica (ex.: deficiência de GH)
Pais	Baixos	História de “puberdade tardia” em um dos pais	Variados
Velocidade de crescimento	Normal	Normal	**Baixa**
Idade óssea	Igual à cronológica	**Atrasada**	Atrasada
Puberdade	Normal	Atrasada	Variada
Estatura final	Baixa, dentro do alvo	**Normal**	Comprometida sem tratamento

Mnemônico: “Familiar: tudo normal, só é baixo. Constitucional: atrasado, mas chega lá.”

Outras causas

- **PIG (pequeno para a idade gestacional):** abaixo do percentil 10 ao nascer; simétrico (agressão precoce, pior prognóstico) ou assimétrico (agressão tardia, poupa o crescimento cerebral).
- **Síndromes:** Noonan, Russell-Silver, Seckel, Bloom, Turner, Down. Toda menina com baixa estatura sem causa aparente deve ter Turner considerado.
- **Deficiência de GH:** 1 em 4.000. Nas formas graves congênitas: **hipoglicemia neonatal, icterícia prolongada e micropênis**.

[complemento] Exames iniciais habituais: hemograma, função renal, eletrólitos, gasometria, urina, parasitológico, TSH e T4 livre, IGF-1, anticorpos para doença celíaca, cariótipo em meninas e idade óssea.

Quando encaminhar ao endocrinologista

- Estatura abaixo de −3 DP.
- Abaixo de −2 DP com velocidade de crescimento baixa.
- Mais de 1,5 DP abaixo da estatura alvo.
- Sinais de lesão do sistema nervoso central ou deficiência de múltiplos hormônios hipofisários.
- Sinais neonatais sugestivos (hipoglicemia, icterícia prolongada, micropênis).

Indicações de hormônio do crescimento

Indicação	Ganho esperado
Deficiência de GH	Cerca de 25 cm
Turner	5 a 10 cm
PIG sem recuperação (catch-up)	Indicado
Baixa estatura familiar	Controverso; 4 a 6 cm

> **Como cai na prova.** (1) Idade óssea atrasada com VC normal e pai que “cresceu tarde” = atraso constitucional, conduta expectante. (2) Idade óssea igual à cronológica com pais baixos = familiar. (3) VC baixa é sempre patológica até prova em contrário. (4) Estatura alvo: soma 13 para menino, subtrai 13 para menina. (5) Micropênis com hipoglicemia neonatal = deficiência de GH.

Aula 13. Puberdade precoce

Definição: surgimento de caracteres sexuais secundários antes dos **8 anos nas meninas** (telarca, M2) e antes dos **9 anos nos meninos** (aumento testicular, G2 = volume testicular de 4 mL). O estadiamento usa Tanner: M (mamas), P (pelos pubianos), G (genitais).

Sequência normal na menina: telarca, pubarca, pico de crescimento entre M2 e M3, menarca de 2 a 2,5 anos após a telarca.

Central ou periférica: a pergunta central

	Central (dependente de gonadotrofinas)	Periférica (independente) **[complemento]**
Mecanismo	Ativação precoce do eixo hipotálamo-hipófise-gônada	Hormônio sexual produzido fora do eixo (tumor, cisto ovariano, adrenal)
Frequência	80% dos casos	20%
LH após estímulo	Alto	Suprimido
Sequência puberal	Harmônica (a ordem normal, só adiantada)	Muitas vezes desarmônica

	Central (dependente de gonadotrofinas)	Periférica (independente) **[complemento]**
Tratamento com análogo de GnRH	**Funciona**	Não funciona

Sexo muda a causa: nas meninas a forma central é 10 a 23 vezes mais comum e quase sempre **idiopática**; nos meninos, cerca de 2/3 têm **lesão do sistema nervoso central**. Por isso o menino com puberdade precoce sempre precisa de imagem.

Fatores de risco: menarca precoce materna, história paterna, baixo peso ao nascer, obesidade (a leptina sinaliza reserva energética e ativa o eixo), exposição a ftalatos (disruptores endócrinos).

Diagnóstico

1. Relação LH/FSH acima de 1 sugere ativação central.
2. **Teste de estímulo com GnRH é o padrão-ouro** nas meninas.
3. Idade óssea avançada (1 ano ou mais, ou acima de 2 DP), porque os estrógenos aceleram a maturação óssea e fecham a cartilagem de crescimento precocemente.
4. Ressonância magnética de crânio em todas as crianças abaixo de 6 anos (e em todos os meninos).

Tratamento

Análogos de GnRH (leuprorrelina, triptorrelina, gosserrelina), apenas na forma central. Por que funcionam: o estímulo contínuo dessensibiliza o receptor hipofisário e desliga o eixo.

- A primeira dose pode causar sangramento vaginal transitório (efeito “flare” inicial antes da supressão).
- Acompanhar a cada 3 meses.
- Suspender quando a idade óssea atingir 12,5 anos nas meninas e 13,5 anos nos meninos.
- Iniciar antes dos 6 anos rende ganho de 9 a 10 cm na estatura final.
- O objetivo é preservar estatura final e proteger o aspecto psicossocial.

Caso da aula: menina com broto mamário unilateral isolado, sem outros sinais: observar por 6 meses (telarca precoce isolada é frequente e benigna).

> **Como cai na prova.** (1) Limites: 8 anos menina, 9 anos menino. (2) Menina: idiopática; menino: lesão do SNC. (3) Padrão-ouro: teste do GnRH. (4) Ressonância abaixo de 6 anos. (5) Análogo de GnRH não trata a forma periférica. (6) Sangramento após a primeira dose é esperado. (7) Broto unilateral isolado: observar 6 meses.

Aula 15. Doenças exantemáticas

O diagnóstico diferencial dos exantemas se resolve com quatro perguntas: (1) qual a idade, (2) como é o pródromo, (3) qual a relação entre a febre e o exantema, (4) qual o sinal patognomônico. A tabela abaixo é o resumo mais importante desta aula; depois vêm os detalhes de cada doença.

Tabela-mestra

Doença	Agente	Idade	Febre e exantema	Sinal-chave	Tratamento
Sarampo	Morbillivirus	Maior risco de 6 a 12 meses	Exantema no 3º a 4º dia de febre alta; febre persiste junto	Tríade tosse, coriza, conjuntivite; manchas de Koplik	Vitamina A
Rubéola	Rubivirus	Crianças e adultos jovens	Febrícula; exantema róseo some em 3 dias	Linfonodos retroauriculares, occipitais e cervicais posteriores uma semana antes	Sintomático
Escarlatina	Estreptococo do grupo A com toxina eritrogênica	5 a 15 anos	Febre alta, amigdalite, exantema em 24 a 48 h	Pele em lixa, sinal de Pastia, Filatov, língua em morango	Penicilina ou amoxicilina
Exantema súbito (roséola)	Herpesvírus humano 6 (e 7)	6 meses a 3 anos (média 9 meses)	**Exantema surge quando a febre cai**	Febre alta sem foco por 3 a 5 dias	Sintomático
Eritema infeccioso	Parvovírus B19	Escolares	**Sem febre na fase exantemática**	Face esbofeteada; exantema rendilhado que volta com calor	Sintomático
Varicela	Vírus varicela-zoster	Crianças	Febre proporcional ao número de lesões	Polimorfismo regional, distribuição centrípeta	Sintomático; aciclovir em casos especiais

Doença	Agente	Idade	Febre e exantema	Sinal-chave	Tratamento
Mononucleose	Vírus Epstein-Barr	Adolescentes e escolares	Febre, faringite, adenopatia	Exantema após amoxicilina; esplenomegalia	Sintomático
Kawasaki	Vasculite, causa desconhecida	85% abaixo de 5 anos	Febre de 5 dias ou mais sem resposta a antibiótico	Conjuntivite sem secreção, lábios fissurados, edema de mãos e pés	Imunoglobulina e AAS
Meningococcemia	Neisseria meningitidis	Qualquer	Febre alta, toxemia contínua	Petéquias e púrpuras que progridem em horas	Ceftriaxona e suporte intensivo
SSJ e NET	Medicamento	Qualquer	Semanas após o fármaco	Bolhas, descolamento, mucosas	Suspender o fármaco; imunoglobulina

Sorologia geral: IgM costuma positivar por volta do 5º dia de doença; aumento de 4 vezes do IgG entre duas amostras confirma infecção recente. Exantemas por medicamento, EBV e enterovírus podem assumir qualquer padrão.

Sarampo

- **Transmissão:** aerossóis (máscara N95), de 4 dias antes a 4 dias após o exantema. Incubação de 8 a 12 dias.
- **Evolução:** pródromo com febre alta e a tríade tosse, coriza e conjuntivite; **manchas de Koplik** na mucosa jugal 1 a 2 dias antes do exantema; exantema morbiliforme no 3º a 4º dia, de progressão **craniocaudal**, que escurece (acastanhado) e descama em furáceo; some por volta do 9º dia.
- **Febre que persiste após o exantema sugere complicação** (otite, pneumonia). Maior risco de complicação abaixo de 5 anos e acima de 20 anos. Panencefalite esclerosante subaguda (PEES) surge 7 a 10 anos depois, com risco maior se o sarampo ocorreu antes dos 2 anos.
- **Tratamento:** vitamina A; ribavirina apenas em imunossuprimidos.
- **Vacina:** tríplice viral aos 12 meses e segunda dose aos 15 meses (tetraviral); duas doses até 29 anos, uma dose de 30 a 49 anos. Em surtos, “dose zero” de 6 a 12 meses, que não conta para o esquema.
- **Pós-exposição:** vacina de bloqueio em até 72 h; imunoglobulina em até 6 dias (protege cerca de 4 semanas).

Rubéola

- Transmissão de 5 a 7 dias antes até 5 a 7 dias após o exantema; incubação de 2 a 3 semanas.
- **Linfadenomegalia retroauricular, occipital e cervical posterior** aparece cerca de uma semana antes do exantema e persiste por semanas. Exantema róseo, começa na face, dissemina rápido e some em cerca de 3 dias sem descamar ("doença dos três dias"). Hemograma pode mostrar plasmocitose.
- **Sarampo versus rubéola:** o sarampo é lento, toxemiante e descama; a rubéola é rápida, leve e não descama.
- Complicações: encefalite, púrpura trombocitopênica, artrite, miocardite; a mais grave é a síndrome da rubéola congênita. Imunoglobulina só em gestantes.

Escarlatina

- Idade de 5 a 15 anos, incubação de 1 a 7 dias. Febre alta (39 a 40 °C), amigdalite purulenta e petéquias no palato.
- Exantema em "**pele em lixa**" nas primeiras 24 a 48 h, começando em pescoço, axilas e virilha; **sinal de Pastia** (acentuação em dobras); **sinal de Filatov** (palidez perioral).
- **Língua:** saburrosa (branca) nos dias 1 e 2, depois **em morango** quando a camada branca descama.
- Descamação lamelar a partir da 1ª semana, mais evidente entre a 2ª e a 3ª semana, em mãos e pés.
- Leucocitose e eosinofilia. Tratamento com penicilina ou amoxicilina, que **previne febre reumática, mas não a glomerulonefrite pós-estreptocócica**.

Exantema súbito (roséola infantil)

- Herpesvírus humano 6 (e 7). De 6 meses a 3 anos, média de 9 meses (queda dos anticorpos maternos). Incubação de 7 a 17 dias.
- Febre alta sem foco por 3 a 5 dias, com convulsão febril em 10 a 15%. **A febre desaparece subitamente e só então surge o exantema**, máculo-papular discreto, no tronco e pescoço, durando de horas a 3 dias, sem descamação.
- Leucocitose com neutrofilia nos dias 1 e 2 (confunde com bactéria), depois leucopenia com linfocitose. Ganciclovir só em imunossuprimidos.

Eritema infeccioso (quinta doença)

- Parvovírus B19, com tropismo por precursores eritroides da medula. Escolares (a aula cita 5 a 15 anos no caso e 2 a 12 anos nas características). Gotículas; transmite mais **antes** do exantema. Incubação de 5 a 10 dias; pródromo leve de 2 dias.

- **Três fases:** (1) face esbofeteada com palidez perioral; (2) após 24 a 48 h, exantema rendilhado em tronco e superfícies extensoras, por 1 a 2 semanas; (3) reaparecimento com exercício, calor, sol, trauma ou estresse, por semanas, **sem ser nova infecção**.
- **Sem febre na fase exantemática**; criança em bom estado.
- **Complicação-chave:** crise aplástica transitória em pacientes com anemia falciforme ou outras anemias hemolíticas (a produção para e as hemácias, que já vivem pouco, não são repostas), podendo exigir transfusão. Em imunodeficientes, infecção crônica, tratada com imunoglobulina.
- Diagnóstico clínico; IgM anti-parvovírus confirma; PCR em imunodeprimidos.

Varicela

- Vírus varicela-zoster (herpesvírus, DNA). Aerossóis e contato com lesões (N95); transmite de 2 dias antes do exantema **até todas as lesões virarem crosta**. Incubação de 14 a 16 dias.
- Lesões evoluem em 8 a 48 h: mácula, pápula, vesícula ("gota de orvalho sobre pétala de rosa"), pústula, crosta. Surgem em **surtos** (3 a 5 por dia), por isso coexistem lesões em todos os estágios: **polimorfismo regional**. Distribuição **centrípeta** (tronco, face, couro cabeludo). Acomete mucosas.
- A febre acompanha o surgimento de novas lesões e cede quando elas param.
- Formas graves em adolescentes e adultos (pneumonite varicelosa).
- **Tratamento:** sintomático (antitérmico, anti-histamínico, cuidado com a pele). Aciclovir para imunocomprometidos, casos graves e risco de complicação.
- **Profilaxia:** vacina a partir de 12 meses. Pós-exposição: vacina em até 5 dias; imunoglobulina específica em até 10 dias para alto risco.

Mononucleose infecciosa

- Vírus Epstein-Barr; saliva e secreções orais; eliminação viral por meses. **Incubação longa, de 30 a 50 dias.**
- **Tríade: febre, faringite e linfadenopatia** (cervical posterior, múltipla). Fadiga intensa e prolongada. Amigdalite membranosa que imita a estreptocócica. Hepatoesplenomegalia, com risco de ruptura esplênica (evitar esporte de contato).
- **Exantema:** espontâneo em 3 a 8%; após amoxicilina ou ampicilina, em 80 a 100%. **Não é alergia verdadeira à penicilina.**
- Laboratório: linfocitose com **linfócitos atípicos acima de 20%**; anti-VCA IgM confirma infecção aguda; PCR para EBV.

Doença de Kawasaki

- Vasculite aguda de artérias de pequeno e médio calibre; 85% abaixo de 5 anos; principal causa de cardiopatia adquirida na infância. A grande preocupação é o **aneurisma coronariano**.
- **Critérios:** febre por 5 dias ou mais com 4 dos 5 critérios abaixo, ou 3 critérios com aneurisma documentado.

Mnemônico "CREAM" [mnemônico clássico, complemento]:

Letra	Critério	Frequência
C	Conjuntivite bilateral **não exsudativa**	88%
R	Rash (exantema) polimorfo, sem vesículas	Comum
E	Extremidades: edema e eritema palmoplantar; descamação periungueal na fase subaguda (2ª semana)	88 a 94%
A	Adenopatia cervical, geralmente unilateral, acima de 1,5 cm	50 a 75%
M	Mucosa oral: lábios vermelhos e fissurados, língua em morango	90%

- **Cronologia vascular:** inflamação da parede do 6º ao 9º dia; aneurismas começam por volta do 10º dia, com pico na 3ª semana, raros após 4 semanas. São silenciosos, por isso ecocardiograma seriado.
- **Laboratório:** anemia normocítica, leucocitose acima de 20.000, VHS e PCR altos, **plaquetose na 3ª semana**, hipoalbuminemia, transaminases altas, **piúria estéril**, autoanticorpos negativos.
- **Tratamento:** imunoglobulina endovenosa 2 g/kg dose única, idealmente até o 10º dia de febre (reduz aneurismas de 25% para menos de 4%), com AAS em dose moderada (30 a 50 mg/kg/dia) ou alta (50 a 80 mg/kg/dia); após 48 h afebril, AAS 3 a 5 mg/kg/dia por 6 a 8 semanas (ou mais, se houver alteração coronariana).

Kawasaki versus escarlatina: ambos têm língua em morango, mas Kawasaki não responde a antibiótico, tem edema de extremidades, exantema polimorfo e descamação perineal precoce.

Farmacodermias: SSJ e NET

- Medicamentos mais envolvidos: analgésicos e AINE (38%), antimicrobianos (36%), anticonvulsivantes (24%), corticoides (14%). Destaques: **fenobarbital, carbamazepina, fenitoína**, sulfonamidas, penicilinas, cefalosporinas, alopurinol.
- Latência de semanas após o início do fármaco (no caso da aula, cerca de 1 mês após fenobarbital).
- **Espectro pela área de descolamento:** Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) abaixo de 10% da superfície corporal com 2 ou mais mucosas; sobreposição de 10 a 30%; Necrólise Epidérmica Tóxica (NET) acima de 30%. Eritema multiforme é mais benigno, com lesões em alvo e pouco ou nenhum acometimento mucoso.
- **Mecanismo:** o fármaco ativa o sistema imune, que produz ligante de Fas (FasL); ele se liga ao receptor do queratinócito e dispara apoptose em massa, descolando a epiderme.
- **Conduta:** suspender imediatamente o fármaco; tratar como grande queimado (internação, hidroeletrolítico, cuidado de pele e mucosas, avaliação oftalmológica). Imunoglobulina adjuvante (2 g/kg dose única, ou 1 g/kg/dia por 2 dias, ou 500 mg/kg/dia por 4 dias), que bloqueia a ligação FasL-receptor.

Meningococcemia

- Neisseria meningitidis; gotículas (máscara cirúrgica); incubação de 1 a 10 dias, média de 4.
- Início abrupto, febre acima de 39,5 °C, **prostração mesmo sem febre** (a virose melhora quando a febre cede; a meningococcemia não).
- Petéquias de distribuição centrífuga (membros inferiores, conjuntivas, mucosas) que evoluem em horas para púrpuras, equimoses e necrose. Em 12 a 24 h pode haver choque, CIVD e falência de múltiplos órgãos.
- **Mecanismo:** coloniza a nasofaringe; cepas com IgA protease atravessam a mucosa; a endotoxina (LPS) causa lesão endotelial, vasodilatação, CIVD e depressão miocárdica. Hemorragia adrenal maciça = síndrome de Waterhouse-Friderichsen.
- **Regra de ouro:** criança febril com petéquias é meningococcemia até prova em contrário. Internar, antibiótico endovenoso (cefalosporina de 3ª geração) imediatamente, sem esperar exames, e suporte intensivo.

> **Como cai na prova.** (1) Exantema que aparece quando a febre some: exantema súbito. (2) Exantema com febre persistente após seu surgimento no sarampo: complicação. (3) Amigdalite, amoxicilina e exantema: mononucleose, não alergia. (4) Lesões em vários estágios: varicela. (5) Anemia falciforme com piora súbita da anemia e reticulócitos baixos: parvovírus B19. (6) Febre de 6 dias sem resposta a antibiótico, lábios fissurados e edema de mãos: Kawasaki, imunoglobulina até o 10º dia. (7) Pele em lixa com Pastia: escarlatina. (8) Linfonodo retroauricular antes do exantema: rubéola. (9) Bolhas e mucosas 1 mês após anticonvulsivante: SSJ, suspender o fármaco. (10) Petéquias com prostração mesmo afebril: meningococcemia.

Mapa de medicamentos: quando usar qual

Esta é a tabela de revisão da véspera. Leia a coluna “Situação”, cubra o resto e tente responder antes de olhar.

Antibióticos por situação

Situação	1ª escolha	Alternativa ou falha	Duração
Amigdalite estreptocócica	Penicilina benzatina IM (600.000 UI abaixo de 27 kg; 1.200.000 acima) ou amoxicilina	Falha: amoxicilina com clavulanato. Alergia leve: cefalexina. Grave: clindamicina ou azitromicina	10 dias (azitromicina 5)
Abscesso periamigdaliano	Drenagem mais amoxicilina com clavulanato	Clindamicina	
Otite média aguda	Amoxicilina (dose alta se creche ou antibiótico recente)	Amoxicilina com clavulanato, cefuroxima; 3ª linha ceftriaxona IM 1 a 3 dias	5 a 7 dias acima de 2 anos; 7 a 10 abaixo
Sinusite bacteriana	Amoxicilina	Amoxicilina com clavulanato em dose alta se risco de resistência	10 a 14 dias
PAC típica ambulatorial	Amoxicilina		5 a 7 dias

Situação	1ª escolha	Alternativa ou falha	Duração
PAC atípica ou pneumonia afebril do lactente	Azitromicina	Claritromicina	5 dias
PAC internada a partir de 2 meses	Ampicilina ou penicilina cristalina EV	Oxacilina se S. aureus; ceftriaxona mais oxacilina se derrame complicado	
Infecção neonatal precoce (pneumonia ou meningite)	Ampicilina mais gentamicina	Ampicilina mais cefotaxima na meningite	
Pneumonia neonatal tardia	Oxacilina mais gentamicina		
Meningite acima de 1 mês	Ceftriaxona ou cefotaxima	Mais vancomicina se pneumococo resistente	Meningo 5 a 7; Hib 7 a 10; pneumo 10 a 14
Meningococcemia	Cefalosporina de 3ª geração imediatamente		
Coqueluche (tratamento e profilaxia)	Azitromicina		5 dias
Escarlatina	Penicilina ou amoxicilina		10 dias
Neutropenia febril	Cefepime		
Diarreia com indicação de antibiótico	Ciprofloxacino para Shigella **[complemento]**	Ceftriaxona se grave	
Quimioprofilaxia de meningococo	Rifampicina 12/12 h por 2 dias	Ceftriaxona ou ciprofloxacino em dose única	
Quimioprofilaxia de Hib	Rifampicina 1 vez ao dia por 4 dias		

Antibióticos proibidos ou ruins em certas situações

- **Cefalexina:** não em OMA, sinusite ou pneumonia.
- **Ceftriaxona:** não abaixo de 28 dias de vida.
- **Cefalosporinas:** não cobrem Listeria (por isso ampicilina no recém-nascido).
- **Macrolídeos:** não como 1ª linha em sinusite ou OMA.
- **Amoxicilina na mononucleose:** provoca exantema em 80 a 100%.

Não antibióticos

Doença	Medicamento e dose	Observação
Anemia ferropriva	Ferro 3 a 6 mg/kg/dia por 3 a 6 meses	Profilaxia 1 mg/kg/dia
PTI	Observação; corticoide ou imunoglobulina se sangramento	
Crise asmática	Salbutamol; ipratrópio na moderada a grave; sulfato de magnésio 25 a 75 mg/kg (máx. 2 g) na grave	Ipratrópio sem benefício após internação
Asma, manutenção	Corticoide inalatório	Montelucaste é o único antileucotrieno abaixo de 12 anos
Bronquiolite	Nenhum fármaco de rotina; O2 se saturação abaixo de 92%	Palivizumabe e nirsevimabe são prevenção
Meningite bacteriana	Dexametasona 0,15 mg/kg 6/6 h por 2 a 4 dias	Antes ou junto do antibiótico
Encefalite herpética	Aciclovir EV	Sem esperar confirmação
Diarreia aguda	SRO, zinco 10 ou 20 mg por 10 dias, ondansetrona	Manter alimentação
TEA	Melatonina (sono); risperidona ou aripiprazol (irritabilidade)	Não tratam o núcleo do autismo
TDAH	Metilfenidato ou lisdexanfetamina (1ª); atomoxetina (2ª)	Com terapia cognitivo-comportamental
Dismenorreia	Ácido mefenâmico ou ibuprofeno (1ª); anticoncepcional oral (2ª)	

Doença	Medicamento e dose	Observação
Ginecomastia	Tamoxifeno	Cirurgia se critérios
Puberdade precoce central	Análogo de GnRH	Suspender com IO 12,5 (meninas) e 13,5 (meninos)
Calazar	Anfotericina B lipossomal	
Sarampo	Vitamina A	Ribavirina só em imunossuprimido
Varicela	Sintomático; aciclovir em imunocomprometido ou grave	
Kawasaki	Imunoglobulina 2 g/kg mais AAS	AAS 3 a 5 mg/kg/dia após 48 h afebril
SSJ e NET	Suspender o fármaco; imunoglobulina	
Coqueluche com convulsão	Fenobarbital	

Banco de 30 questões

Faça as 30 em 60 minutos, sem consultar, marcando a resposta no papel. Só depois abra o gabarito. Nas questões de afirmativas, as alternativas são sempre: A) 1; B) 2; C) 3; D) 4.

1. Lactente de 18 meses, em uso de leite de vaca integral desde os 8 meses, é trazido por palidez. A mãe conta que ele “vive pedindo gelo”. Hemoglobina 9,0 g/dL, VCM 68 fL, RDW 19%, reticulócitos baixos. A conduta mais adequada é:

- A) Ácido fólico por 3 meses.
- B) Ferro elementar 3 a 6 mg/kg/dia por 3 a 6 meses, com reavaliação em 30 a 45 dias.
- C) Transfusão de concentrado de hemácias.
- D) Ferro elementar 1 mg/kg/dia até os 2 anos.

2. Sobre o hemograma na pediatria, quantas afirmativas estão corretas?

I. O RDW elevado pode preceder a queda do VCM na deficiência de ferro.

II. A reação leucemoide caracteriza-se por leucócitos acima de 50.000/mm³ com predomínio de blastos.

III. Neutropenia grave corresponde a contagem de neutrófilos abaixo de 500/mm³.

IV. Na púrpura trombocitopênica imune da infância, a maioria dos pacientes necessita de corticoide.

3. Criança de 20 kg receberá amoxicilina 50 mg/kg/dia de 8/8 h. A suspensão disponível é de 250 mg/5 mL. O volume por tomada é:

- A) 6,7 mL.
- B) 5 mL.
- C) 10 mL.
- D) 13,3 mL.

4. Adolescente de 16 anos com febre, faringite exsudativa, adenomegalia cervical posterior e fadiga intensa recebeu amoxicilina. No segundo dia surgiu exantema máculo-papular difuso. Ao exame, baço palpável. Assinale a alternativa correta:

- A) Trata-se de alergia verdadeira à penicilina, e betalactâmicos devem ser contraindicados por toda a vida.
- B) O quadro é típico de escarlatina, e o exantema é causado pela toxina eritrogênica.
- C) O diagnóstico provável é mononucleose; espera-se linfocitose com linfócitos atípicos e deve-se orientar evitar esportes de contato.
- D) Trata-se de doença de Kawasaki, com indicação de imunoglobulina.

5. Menino de 8 anos, 22 kg, com início abrupto de febre de 39,5 °C, dor de garganta, exsudato amigdaliano e linfonodos cervicais anteriores dolorosos, sem tosse ou coriza. A conduta mais adequada é:

- A) Penicilina benzatina 600.000 UI IM em dose única.
- B) Amoxicilina com clavulanato por 10 dias como primeira escolha.
- C) Sintomáticos, pois a maioria das amigdalites é viral.
- D) Azitromicina por 5 dias como primeira escolha.

6. Lactente de 5 meses com febre de 38,2 °C e irritabilidade. A otoscopia mostra abaulamento da membrana timpânica direita. A conduta é:

- A) Observar por 48 a 72 h, pois a febre é menor que 39 °C.
- B) Cefalexina por 10 dias.
- C) Apenas gotas otológicas e analgésico.
- D) Amoxicilina.

7. Sobre a sinusite bacteriana aguda na criança, quantas afirmativas estão corretas?

I. O seio frontal desenvolve-se por volta dos 7 a 8 anos.

II. O diagnóstico exige radiografia dos seios da face.

III. Praticamente 100% das cepas de Moraxella catarrhalis produzem betalactamase.

IV. Sintomas persistentes por mais de 10 dias sem melhora constituem um dos critérios diagnósticos.

8. Lactente de 10 meses com febre e tosse há 3 dias. FR de 56 irpm, tiragem subcostal, saturação de 93%. A conduta mais adequada é:

- A) Amoxicilina ambulatorial e retorno em 48 h.
- B) Azitromicina ambulatorial por 5 dias.
- C) Internação e ampicilina endovenosa.
- D) Lavagem nasal e observação domiciliar.

9. Lactente de 7 semanas, afebril, com tosse em acessos curtos e taquipneia. Teve conjuntivite aos 15 dias de vida. Hemograma com eosinofilia. Agente e tratamento mais prováveis:

- A) Streptococcus pneumoniae; amoxicilina.
- B) Vírus sincicial respiratório; suporte.
- C) Staphylococcus aureus; oxacilina.
- D) Chlamydia trachomatis; azitromicina.

10. Sobre o derrame pleural parapneumônico, quantas afirmativas estão corretas?

I. Na fase exsudativa, o tratamento é feito apenas com antibiótico.

II. pH do líquido pleural abaixo de 7,1 indica drenagem.

III. A ultrassonografia detecta volumes menores que a radiografia em decúbito lateral.

IV. Na fase de organização, que ocorre em 2 a 4 semanas, pode ser necessária decorticação.

11. Escolar de 7 anos, asmático, em crise grave: fala apenas palavras, saturação de 89%. Recebeu 3 ciclos de salbutamol com ipratrópio e corticoide sistêmico, sem resposta. O próximo passo é:

- A) Sulfato de magnésio 25 a 75 mg/kg endovenoso, máximo de 2 g.
- B) Manter ipratrópio de 4/4 h após a internação.
- C) Iniciar montelucaste.
- D) Iniciar antibiótico de amplo espectro.

12. Sobre a asma na infância, quantas afirmativas estão corretas?

I. A espirometria deve ser realizada após o início do corticoide inalatório.

II. Abaixo de 5 anos, o diagnóstico é essencialmente clínico.

III. O montelucaste é o único antagonista de leucotrienos utilizado abaixo de 12 anos.

IV. O ipratrópio reduz hospitalização quando usado na emergência, sem benefício após a internação.

13. Lactente de 4 meses, no outono, com 2 dias de coriza e febre baixa, evolui com taquidispneia (FR 58), sibilos e crepitações difusas e saturação de 90%. É o primeiro episódio. A conduta adequada é:

- A) Nebulização com salina hipertônica e corticoide sistêmico.
- B) Oxigênio, aspiração nasal e hidratação.
- C) Salbutamol de horário e prednisolona.
- D) Palivizumabe.

14. Lactente de 2 meses, sem vacinas, com tosse há 12 dias. Após os acessos, apresenta cianose e apneia, sem guincho. Leucócitos 32.000/mm³ com 75% de linfócitos. Assinale a correta:

- A) O diagnóstico provável é coqueluche; tratar com azitromicina e fazer quimioprofilaxia dos contatos domiciliares.
- B) O diagnóstico provável é bronquiolite; o tratamento é de suporte.
- C) A ausência de guincho afasta coqueluche.
- D) A linfocitose indica infecção viral e dispensa antibiótico.

15. Sobre as doenças exantemáticas, quantas afirmativas estão corretas?

I. No exantema súbito, o exantema surge após o desaparecimento da febre.

II. No eritema infeccioso, a criança costuma estar febril durante a fase exantemática.

III. Na varicela, a transmissão persiste até que todas as lesões estejam em crosta.

IV. No sarampo, o exantema tem progressão craniocaudal e evolui com descamação furfurácea.

16. Recém-nascido de 15 dias com febre, irritabilidade e fontanela abaulada. Líquor: 1.200 células (85% neutrófilos), glicose 20 mg/dL, proteína 180 mg/dL. O esquema empírico adequado é:

- A) Ceftriaxona isolada.
- B) Vancomicina isolada.
- C) Aciclovir isolado.
- D) Ampicilina mais gentamicina (ou ampicilina mais cefotaxima).

17. Criança de 4 anos com febre há 3 semanas, cefaleia e paralisia do VI par craniano. Líquor: 250 células (80% linfócitos), glicose 15 mg/dL, proteína 300 mg/dL. O diagnóstico mais provável é meningite:

- A) Por enterovírus.

- B) Pneumocócica.
- C) Tuberculosa.
- D) Herpética.

18. Sobre meningites bacterianas, quantas afirmativas estão corretas?

I. Contatos domiciliares de doença meningocócica podem receber rifampicina de 12/12 h por 2 dias.

II. O profissional de saúde exposto a secreções durante intubação sem EPI deve receber quimioprofilaxia.

III. A ceftriaxona é contraindicada abaixo de 28 dias de vida.

IV. A dexametasona deve ser administrada antes ou junto da primeira dose de antibiótico.

19. Punção lombar traumática mostra 30 leucócitos/mm³ e 10.000 hemácias/mm³. O número de leucócitos corrigido é:

- A) 10.
- B) 20.
- C) 28.
- D) 30.

20. Criança de 1 ano que frequenta creche apresenta vômitos seguidos, um dia depois, de diarreia aquosa abundante. Assinale a correta:

- A) O mecanismo provável é secretor, que persiste com jejum.
- B) O agente mais provável é o rotavírus, com diarreia osmótica por deficiência de lactase.
- C) O antibiótico está indicado por frequentar creche.
- D) A alimentação deve ser suspensa até a melhora.

21. Sobre as diarreias, quantas afirmativas estão corretas?

I. O zinco é indicado na dose de 20 mg/dia por 10 dias para crianças acima de 6 meses.

II. Diarreia persistente é a que dura de 14 a 30 dias.

III. pH fecal abaixo de 5,5 sugere intolerância a carboidratos.

IV. O antibiótico está indicado em toda diarreia aguda abaixo de 2 anos.

22. Criança de 2 anos com diarreia crônica, distensão abdominal e queda do ganho de peso desde a introdução de pães e massas. O exame inicial mais indicado é:

- A) Anticorpo antitransglutaminase.
- B) Calprotectina fecal.

- C) ASCA.
- D) Teste do suor.

23. Escolar de 9 anos com desatenção na escola há 3 meses. Em casa, os pais não notam alterações. A conduta correta é:

- A) Confirmar TDAH e iniciar metilfenidato.
- B) Reconhecer que ainda não há critérios, pois são exigidos 6 meses de sintomas em 2 ou mais ambientes.
- C) Diagnosticar TEA nível 1.
- D) Iniciar atomoxetina como primeira linha.

24. Sobre desenvolvimento, TEA e TDAH, quantas afirmativas estão corretas?

I. O M-CHAT é aplicado entre 18 e 24 meses.

II. A dieta sem glúten e sem caseína tem evidência de benefício no TEA.

III. A atomoxetina tem início de ação imediato.

IV. Criança com atraso de linguagem deve ser encaminhada à fonoaudiologia.

25. Adolescente de 15 anos, menarca aos 12, com cólica menstrual intensa há 1 ano. A primeira linha de tratamento é:

- A) Anticoncepcional oral combinado.
- B) Opioide fraco.
- C) Dispositivo intrauterino.
- D) Anti-inflamatório não esteroide, como ácido mefenâmico.

26. Criança de 6 anos, do interior do Nordeste, com febre há 2 meses, emagrecimento, baço palpável a 10 cm do rebordo, pancitopenia e hipergamaglobulinemia. O diagnóstico e o tratamento são:

- A) Calazar; confirmar com amastigotas no mielograma e tratar com anfotericina B lipossomal.
- B) Leucemia linfoide aguda; quimioterapia.
- C) Doença de Gaucher; reposição enzimática.
- D) Mononucleose; sintomáticos.

27. Menino de 12 anos com estatura no percentil 2, velocidade de crescimento de 5 cm/ano e idade óssea de 10 anos. O pai relata que “cresceu tarde”. A estatura alvo é normal. O diagnóstico e a conduta são:

- A) Deficiência de GH; iniciar hormônio do crescimento.
- B) Baixa estatura familiar; tranquilizar.

- C) Síndrome de Turner; cariótipo.
- D) Atraso constitucional do crescimento; conduta expectante.

28. Uma menina tem pai com 180 cm e mãe com 164 cm. Sua estatura alvo é:

- A) 165,5 cm (160,5 a 170,5 cm).
- B) 178,5 cm.
- C) 172 cm.
- D) 159 cm.

29. Sobre a puberdade precoce, quantas afirmativas estão corretas?

I. Na menina, define-se pelo surgimento de caracteres sexuais antes dos 8 anos.

II. Nos meninos, a forma central é majoritariamente idiopática.

III. O teste de estímulo com GnRH é o padrão-ouro.

IV. Os análogos de GnRH tratam a puberdade precoce periférica.

30. Criança de 3 anos com febre há 7 dias sem resposta à amoxicilina, conjuntivite bilateral sem secreção, lábios fissurados, língua em morango, edema de mãos e linfonodo cervical de 2 cm. A conduta é:

- A) Penicilina benzatina IM.
- B) Aguardar a descamação periungueal para confirmar.
- C) Imunoglobulina endovenosa 2 g/kg com AAS, e ecocardiograma.
- D) Corticoide isolado.

Gabarito comentado

Para cada erro, volte à aula indicada e releia apenas o trecho citado; depois refaça a questão sem olhar.

Questão	Resposta	Por quê	Revisar
1	B	Microcitose, RDW alto, pagofagia e leite de vaca: ferropriva. Tratamento é 3 a 6 mg/kg/dia; 1 mg/kg/dia é dose de profilaxia	Aula 1
2	B (2)	I e III corretas. II falsa: leucemoide tem células maduras; blastos sugerem leucemia. IV falsa: 80 a 85% só observam	Aula 1
3	A	20 × 50 = 1.000 mg/dia; 333 mg por tomada; 333 ÷ 50 mg/mL = 6,7 mL. Atalho: 20 ÷ 3	Aula 2

Questão	Resposta	Por quê	Revisar
4	C	Faringite, adenopatia posterior, fadiga, baço e exantema após amoxicilina: mononucleose. Não é alergia verdadeira	Aula 15
5	A	Quadro típico de estreptococo em escolar; abaixo de 27 kg, 600.000 UI. Amoxicilina com clavulanato fica para falha	Aula 3
6	D	Abaixo de 6 meses a OMA sempre recebe antibiótico; cefalexina não serve para OMA	Aula 3
7	C (3)	I, III e IV corretas. II falsa: o diagnóstico é clínico	Aula 3
8	C	Tiragem subcostal é critério de internação; a partir de 2 meses, ampicilina endovenosa	Aula 4
9	D	Afebril, 1 a 3 meses, conjuntivite prévia e eosinofilia: Chlamydia	Aula 4
10	D (4)	Todas corretas	Aula 4
11	A	Crise grave refratária: sulfato de magnésio. Ipratrópio não ajuda após internação	Aula 5
12	C (3)	II, III e IV corretas. I falsa: espirometria antes do tratamento	Aula 5
13	B	Primeiro chiado abaixo de 2 anos no outono: bronquiolite. Suporte com O2 (saturação abaixo de 92%), aspiração e hidratação. Corticoide e salina hipertônica não são recomendados; palivizumabe só previne	Aula 6
14	A	Abaixo de 6 meses a coqueluche se apresenta com apneia e cianose, sem guincho; linfocitose é típica	Aula 6
15	C (3)	I, III e IV corretas. II falsa: não há febre na fase exantemática do eritema infeccioso	Aula 15
16	D	Recém-nascido: cobrir Listeria com ampicilina; ceftriaxona contraindicada abaixo de 28 dias	Aula 7
17	C	Linfocítica, glicose muito baixa, proteína muito alta, evolução arrastada e par craniano: tuberculose	Aula 7
18	D (4)	Todas corretas	Aula 7
19	A	10.000 ÷ 500 = 20; 30 menos 20 = 10	Aula 7

Questão	Resposta	Por quê	Revisar
20	B	Vômitos antes da diarreia em lactente de creche: rotavírus, mecanismo osmótico. Manter alimentação; sem antibiótico	Aula 8
21	C (3)	I, II e III corretas. IV falsa: antibiótico só se grave, disenteria, imunossupressão ou abaixo de 4 meses	Aula 8
22	A	Diarreia crônica após introdução do glúten aos 1 a 3 anos: doença celíaca	Aula 8
23	B	TDAH exige 6 meses e 2 ambientes; ainda não preenche	Aula 9
24	B (2)	I e IV corretas. II falsa: sem evidência. III falsa: atomoxetina leva 2 a 4 semanas	Aula 9
25	D	Dismenorreia primária: AINE é primeira linha; anticoncepcional é a segunda	Aula 10
26	A	Área endêmica, febre prolongada, baço enorme, pancitopenia e hipergamaglobulinemia: calazar	Aula 11
27	D	Idade óssea atrasada, VC normal, história paterna de crescimento tardio e alvo normal: atraso constitucional	Aula 12
28	A	Menina: (180 − 13 + 164) ÷ 2 = 165,5 cm, mais ou menos 5 cm	Aula 12
29	B (2)	I e III corretas. II falsa: nos meninos 2/3 têm lesão do SNC. IV falsa: análogo só na forma central	Aula 13
30	C	Febre de 5 dias ou mais com 4 critérios (conjuntivite, mucosa, extremidades, adenopatia): Kawasaki. Imunoglobulina até o 10º dia com AAS	Aula 15

Interpretação do resultado. 26 ou mais acertos: revise só os erros e as caixas “Como cai na prova”. De 20 a 25: releia as aulas dos erros na segunda à tarde. Abaixo de 20: priorize, nesta ordem, Aulas 7, 15, 3 e 4, que concentram o maior número de decisões terapêuticas.